Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Suspicion d’AVC

Signe neurologique brutal : visage, bras ou jambe, parole, vue, équilibre. Adulte et enfant : même conduite, chaque minute compte.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · bouche de travers, bras ou jambe qui ne bouge plus, parole troublée, **même si les signes ont disparu** ; ne répond pas, convulse.

1 · Je sécurise

- **Appeler le 15 tout de suite** (ou faire appeler), puis l’IDE.
- Noter **l’heure à laquelle la personne a été vue normale pour la dernière fois**.
- Allonger ou asseoir confortablement ; bouger le moins possible, ne pas faire marcher.
- Ne répond pas normalement ou vomit : **PLS** ; retirer le dentier.

2 · J’observe et je mesure

- **VITE** : **V**isage paralysé (sourire) · **I**mpossible de bouger un membre · **T**rouble de la parole · **E**n urgence : 15.
- Autres signes brutaux : perte de la vue d’un œil, grand déséquilibre, mal de tête brutal et intense.
- TA aux deux bras, pouls, SpO2, température ; **glycémie capillaire (AS/AP)**.
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** Heure de la dernière prise.
- Handicap, non communicant : comparer à l’habituel (équipe, famille, photo, vidéo).

3 · J’agis

- Rester avec la personne, lui parler même si elle comprend mal.
- Au 15 : heure vue normale, signes VITE, glycémie, TA, traitements ; **ne pas raccrocher sans accord**.
- Préparer DLU, ordonnances, directives anticipées ou niveau de soins ; enfant : PAI, prévenir les parents.
- Nuit : ouvrir la porte, éclairer l’accès, envoyer quelqu’un accueillir les secours.

Je ne fais pas

- Donner à manger, à boire ou un médicament, **même le traitement habituel** (fausse route).
- Attendre que « ça passe » : signes disparus = **15 quand même**.
- Resucrer sans accord du 15 : glycémie < 0,70 g/L → le dire au 15, qui décide (risque de fausse route).
- Retarder le 15 pour joindre d’abord l’IDE, le médecin ou la famille.

J’alerte

Appel 15 immédiat si :

- **Dans tous les cas**, au moindre signe, même passager.
- Ne répond plus, respire mal : PLS ; ne respire plus : protocole « Arrêt cardio-respiratoire ».

J’appelle l’IDE (à défaut : médecin d’astreinte ou DOTR) si :

- Toujours, **juste après le 15** (sans le retarder).
- Changement brutal inexpliqué chez une personne non communicante : IDE sans délai ; injoignable → 15.

Je surveille et je trace

- En continu jusqu’aux secours : conscience, respiration, parole, force des bras.
- Aggravation ou nouveau signe : rappeler le 15.
- Tracer : heure vue normale, heure des signes, constantes, glycémie, appels, consignes reçues.

Mention de sécurité

Signe d’AVC, même passager = 15 immédiatement. Noter l’heure vue normale pour la dernière fois ; rien par la bouche.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap, fiches 0 et 12 « Suspicion AVC » (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 12 (2016) ; ASSURE IDF, fiche A (2023) ; HAS, AVC : prise en charge précoce (mai 2009) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-AVC | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature